Boletín Epidemiológico N° 13 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

Ministerio de Salud

10 de abril de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 13 9

Malaria 11

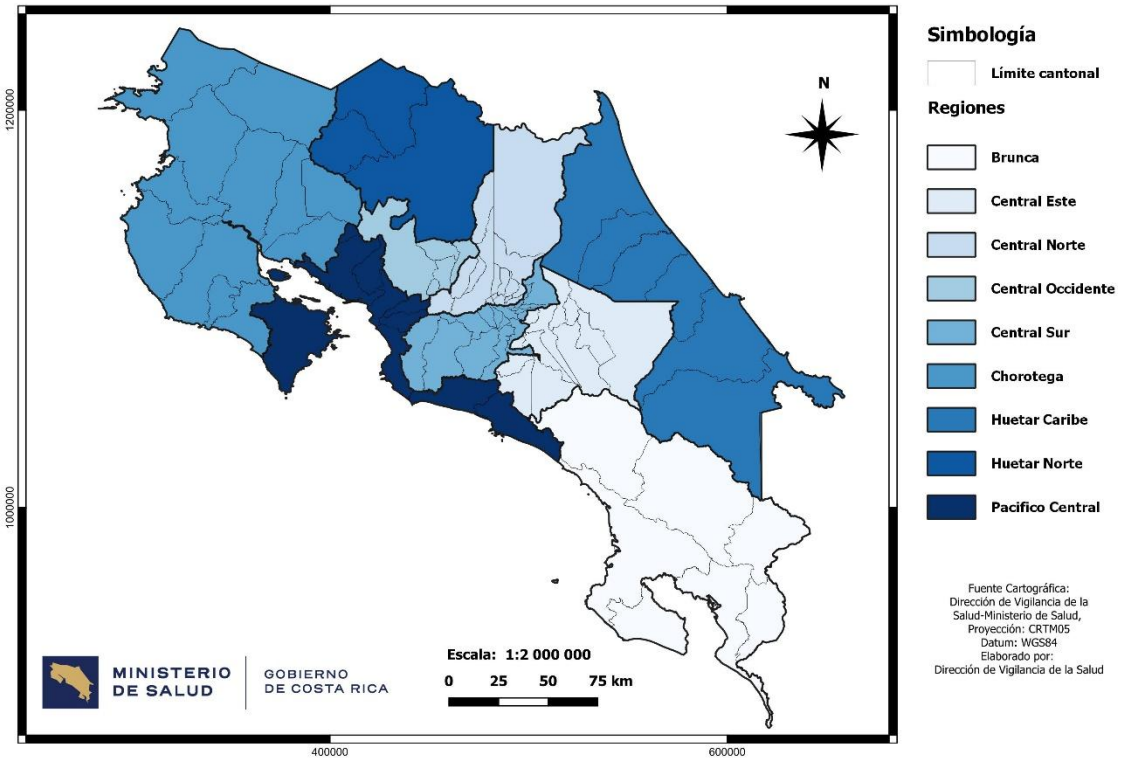
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 18

Infecciones de transmisión sexual 33

Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 8 de abril 2025. 45

Intoxicación por metanol 47

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 13 del año 2025 se notifican **1957 casos** de dengue, de estos 21 acumulados con signos de alarma.

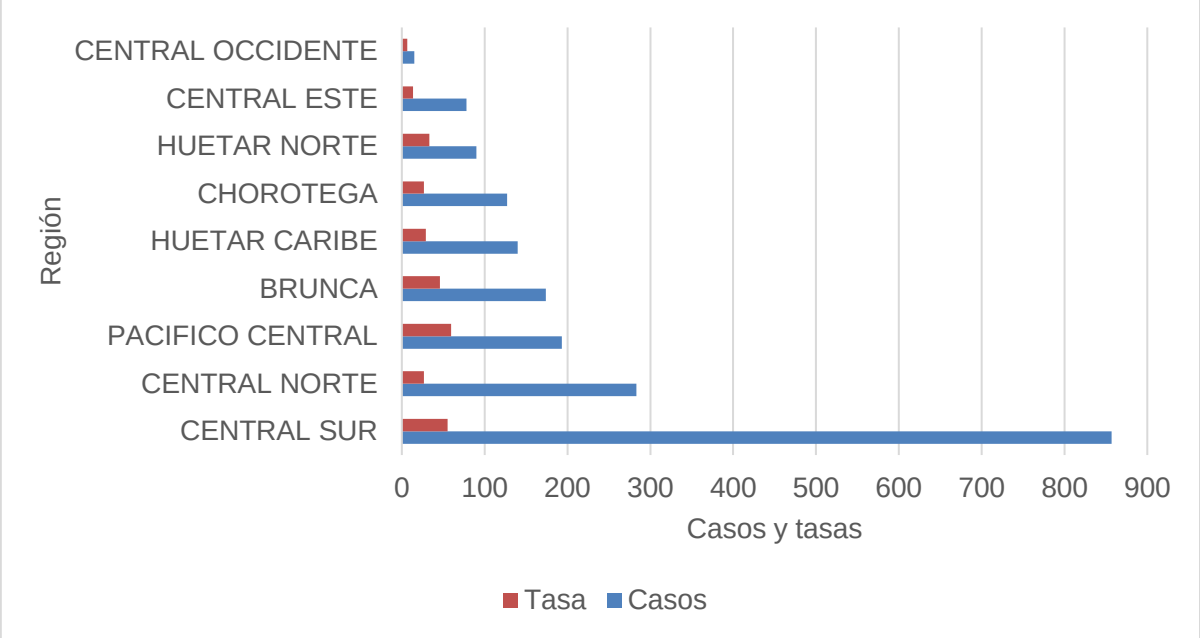
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 857 casos y con la tasa más alta la región Pacífico Central de 59,4/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 13, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	857	55,2
Central Norte	283	26,8
Pacifico Central	193	59,4
Brunca	174	45,9
Huetar Caribe	140	29,0
Chorotega	127	26,6
Huetar Norte	90	33,0
Central Este	78	13,5
Central Occidente	15	6,5
Total	1957	36,5

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 13, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

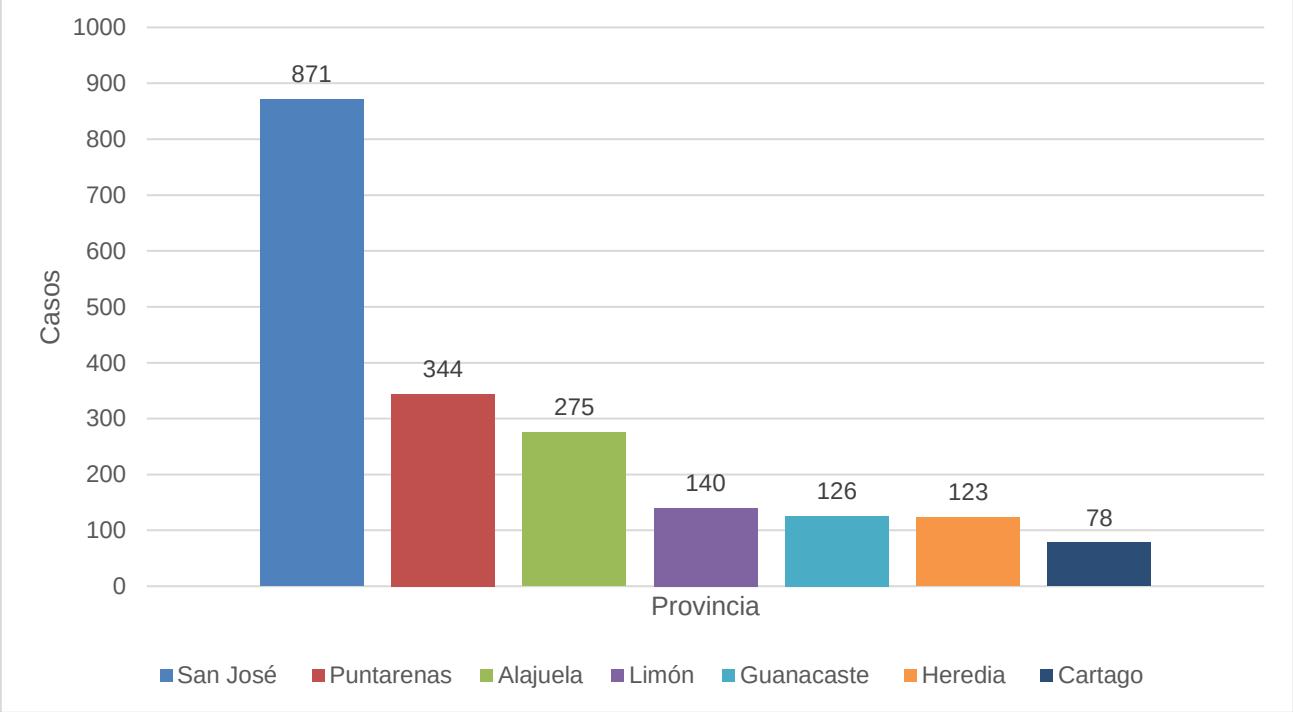
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	871	50,7	435	50,4	436	51,1
Puntarenas	344	65,2	139	53,6	205	76,5
Alajuela	275	25,2	136	25,2	139	25,2
Limón	140	29,0	62	26,4	78	31,4
Guanacaste	126	30,0	51	24,6	75	35,2
Heredia	123	22,0	63	22,6	60	21,4
Cartago	78	14,0	38	13,7	40	14,4
Total	**1957**	**36,5**	**924**	**34,7**	**1033**	**38,4**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 13, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 13 son: San José 572 casos, Alajuela 127 casos, Sarapiquí 71 casos, Puntarenas 71 casos y San Carlos 70 casos.

Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 13, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
101: San José	572	159,8
201: Alajuela	127	38,2
410: Sarapiquí	71	75,1
601: Puntarenas	71	47,6
210: San Carlos	70	32,6
602: Esparza	62	152,1
610: Corredores	62	112,7
605: Osa	60	189,4
110: Alajuelita	59	58,5
103: Desamparados	55	21,6
703: Siquirres	42	63,0
109: Santa Ana	40	62,7
702: Pococí	40	24,9
611: Garabito	38	129,2
113: Tibás	29	33,1
108: Goicoechea	24	16,7
506: Cañas	24	69,8
607: Golfito	23	48,0
303: La Unión	22	18,7
308: El Guarco	20	41,8

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

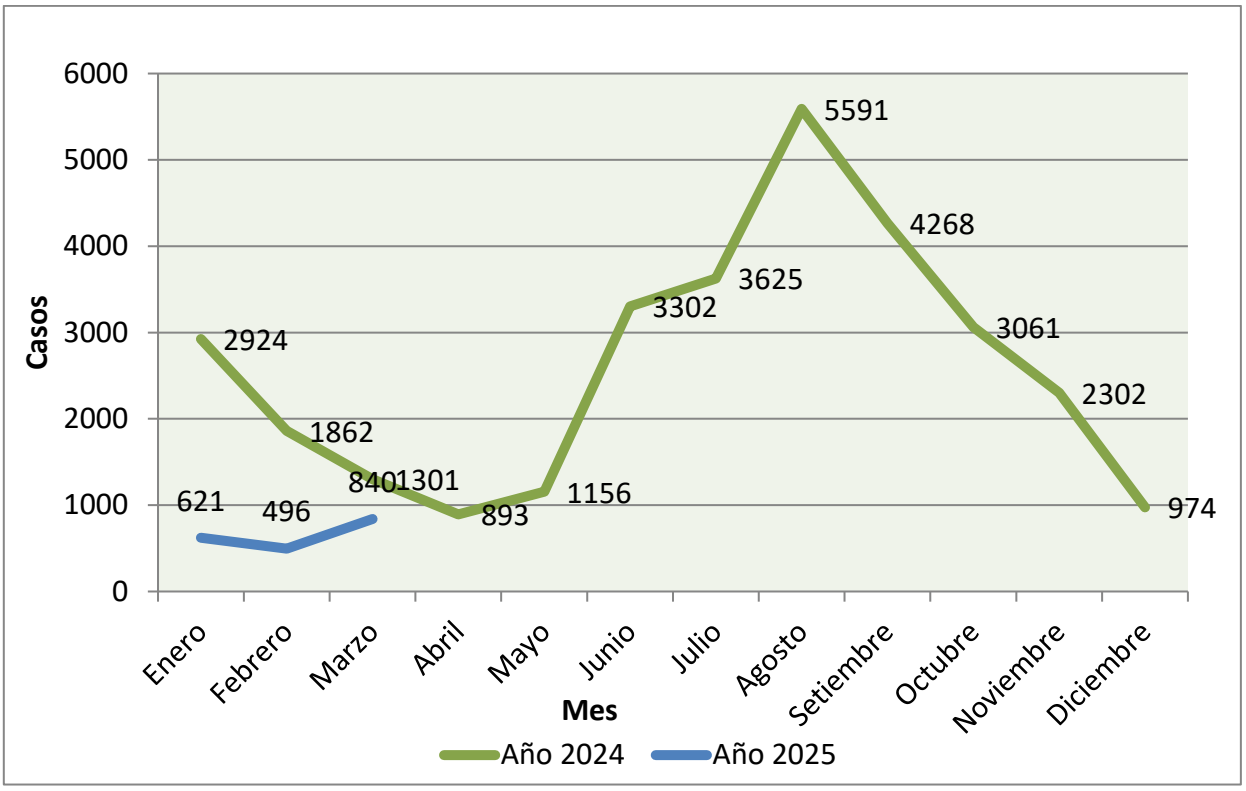
A la semana epidemiológica 13 del 2024 se reportó un total de 6087 casos de dengue, para este 2025 se reportan 1957 para un descenso del 67,8%.

Tabla 4.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 13, 2024-2025.

Semana	2024	2025
1	917	151
2	735	170
3	641	169
4	631	131
5	568	120
6	472	121
7	421	110
8	401	145
9	340	156
10	289	176
11	256	153
12	238	191
13	178	164
Total	**6087**	**1957**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue notificados por mes, 2024- 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

La CCSS no reporta hospitalizaciones al 7 de abril del 2025.

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 13

Rodrigo Marín Rodríguez
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la SE_13 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la SE_13

	Total
Viviendas visitadas	**10.989**
Viviendas positivas	**280**
Depósitos tratados	**46.100**
Depósitos eliminados	**43.873**
Depósitos positivos	**328**
Viviendas fumigadas	**16.960**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Así mismo se detalla lo que llevamos de la SE_1 a la 13.

	Total
Viviendas visitadas	**169.382**
Viviendas positivas	**5.589**
Depósitos tratados	**634.320**
Depósitos eliminados	**385.745**
Depósitos positivos	**10.029**
Viviendas fumigadas	**154.393**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones para alcanzar este objetivo, se están llevando a cabo **supervisiones capacitantes** dirigidas a los funcionarios de la CCSS y el MINSA. Estas supervisiones tienen el propósito de actualizarlos en el manejo de la malaria y fortalecer la implementación de estrategias de control, como la estrategia DTIR, en todo el territorio nacional.

Además, se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

El histórico de transmisión local de malaria presenta los casos registrados en los años 2023, 2024 y 2025, organizados por semana epidemiológica. Se observa una tendencia general a la disminución de casos en el periodo analizado.

Como se muestra en la tabla 1 y gráfico 1 en el año 2023, el total de casos alcanzó los 538, con un pico notable en la semana 12, donde se reportaron 82 casos. Otras semanas con alta incidencia fueron la semana 14 con 52 casos y la semana 15 con 36.

Para el año 2024, la cantidad de casos se redujo significativamente a 244, con un patrón de distribución similar al del año anterior. La semana de mayor incidencia fue la 15 con 17 casos, seguida de la semana 3 con 12 y la semana 5 con 13.

En el inicio del año 2025, a semana epidemiológica 13, se reportaron **6 casos de transmisión local** de malaria por *Plasmodium falciparum* en el foco de Matina, con nexo epidemiológico en las localidades de Matina, Estrada, Bananita y Goly.

Esta reducción progresiva de los casos se relaciona con diversas intervenciones en salud pública, mayor vigilancia epidemiológica y medidas de prevención y control de la malaria en las comunidades afectadas.

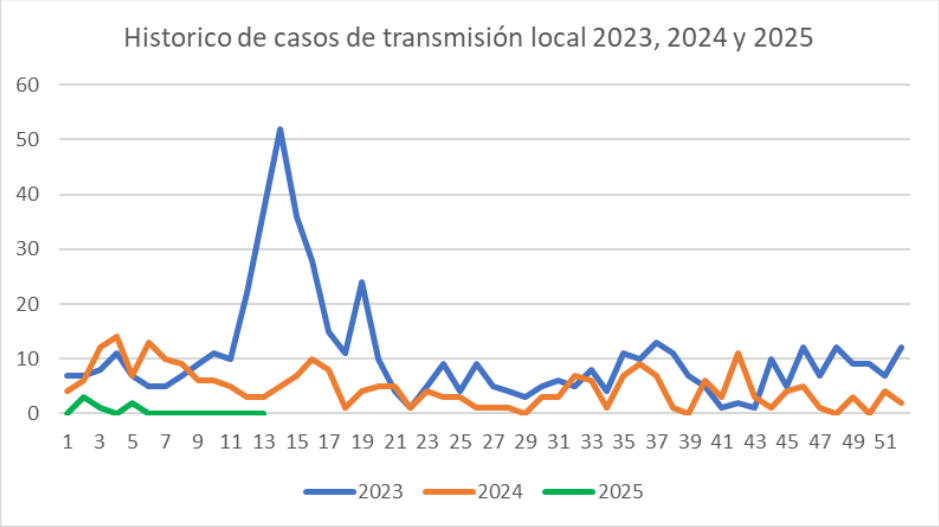
Adicionalmente para el 2025 se han detectado siete casos importados, en los que la transmisión ocurrió fuera del país. Estos corresponden a personas de nacionalidad nicaragüense, nepalí y venezolana. Además, se registró un caso de recaída en 2024, correspondiente a un caso importado, detectado en Corredores, Puntarenas.

Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 13.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0
10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
Total	**146**	**98**	**6**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 13.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.

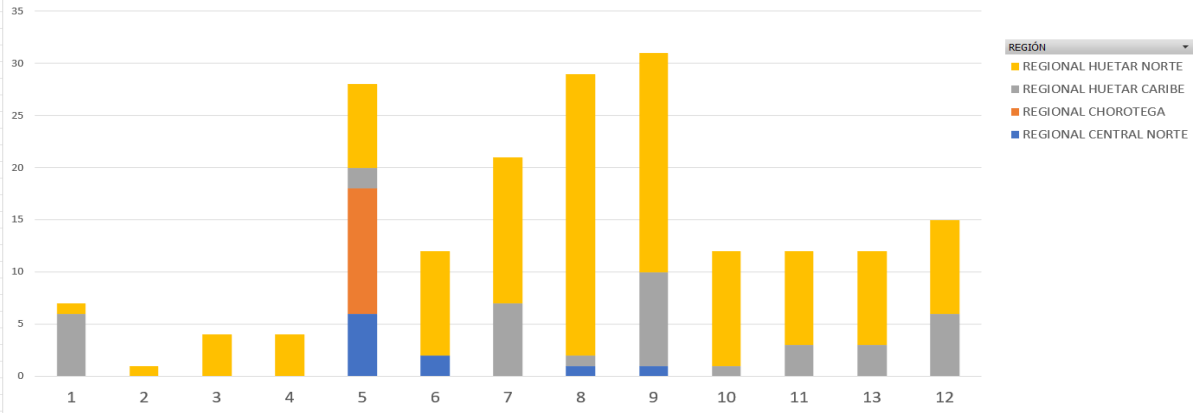
A semana epidemiológica 13, se registraron 27.730 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Gotas gruesas de diagnóstico realizadas por CCSS**:2.722, de las cuales 1406 han sido tomadas por la Región Huetar Caribe, Huetar Norte y Región Brunca del Ministerio de Salud.
- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por la CCSS**: 12.655, referirse al gráfico 2.
- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por la Ministerio de Salud**: 12.353
    - **Colaboradores Voluntarios**: 188 pruebas, en el gráfico 1 se puede ver desagregado por foco y semana epidemiológica.
    - **Inspectores de Salud**: 12.099 pruebas
    - **Establecimientos de salud privados**: 66 pruebas

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

Gráfico 2.

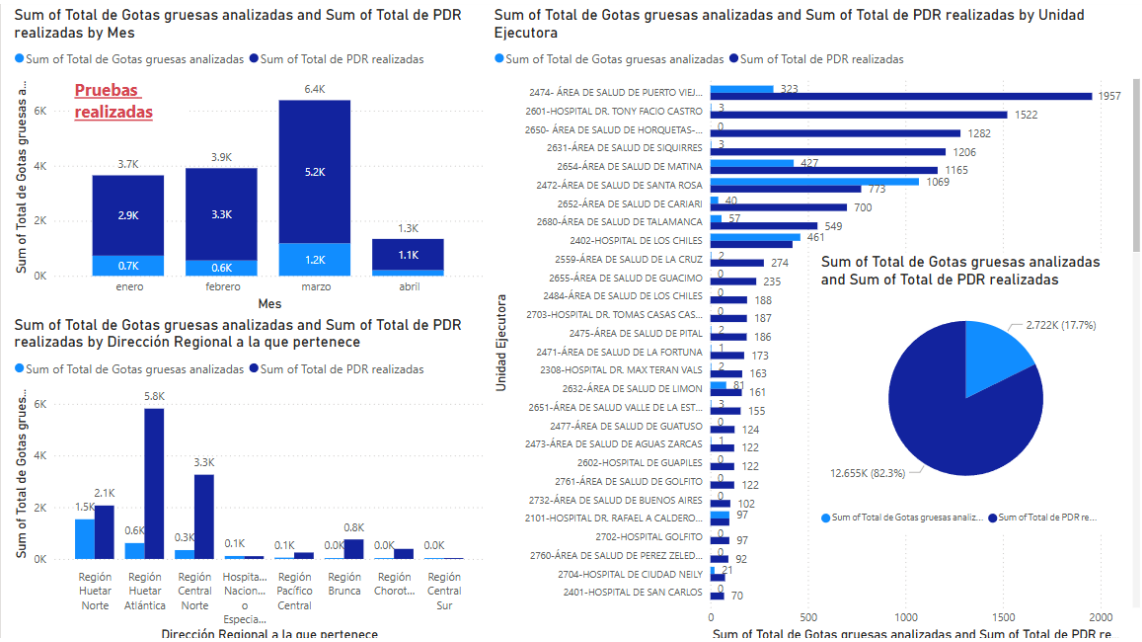
Costa Rica: Producción de pruebas rápida por colaboradores voluntarios desagregado por región



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Gráfico 3.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS



Fuente: CCSS.

Tabla 2.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región

Dirección Regional a la que pertenece	Sum of Total de Gotas gruesas analizadas	Sum of Total de PDR realizadas
Región Huetar Norte	1534	2066
Región Huetar Atlántica	614	5815
Región Central Norte	342	3258
Hospitales Nacionales o Especializados	114	107
Región Pacífico Central	50	248
Región Brunca	29	754
Región Chorotega	24	389
Región Central Sur	15	18
Total	**2722**	**12655**

Fuente: CCSS.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 7 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 4 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a enero 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Activo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

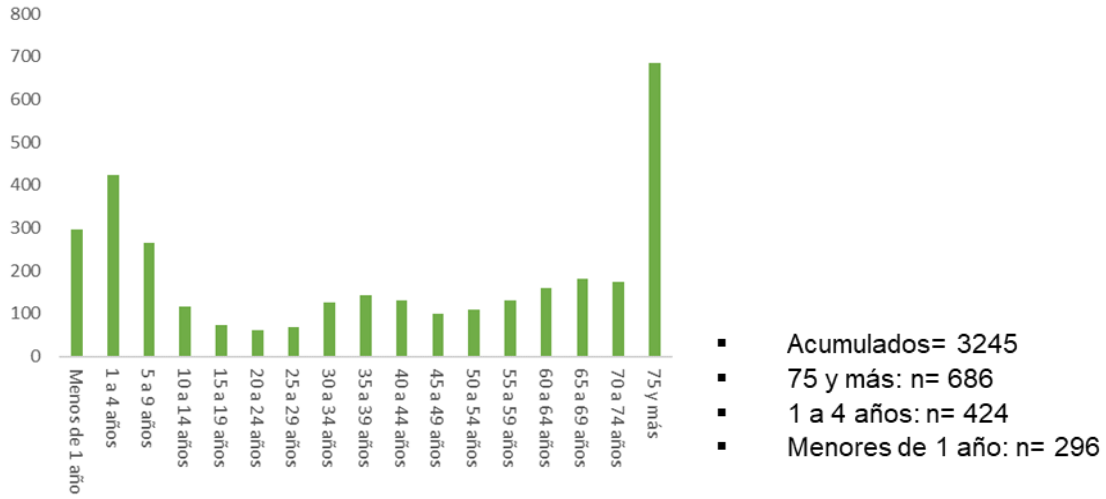
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 13 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 13 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 13 son un total de 3245.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 11, en Costa Rica, 2025.

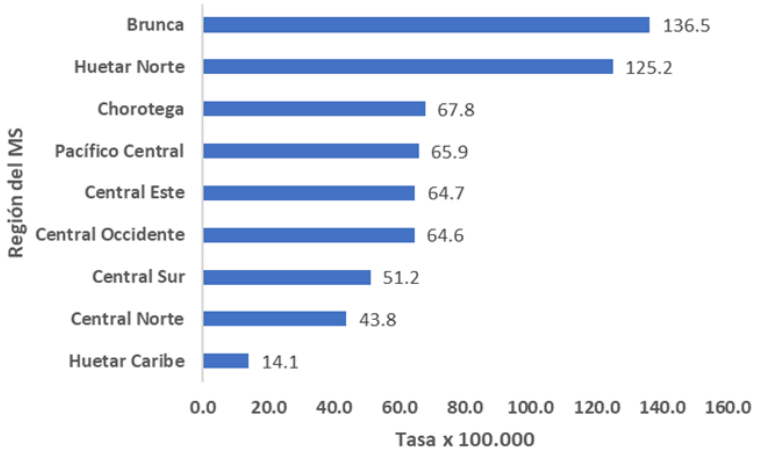


Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).

En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 13, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Brunca y la Huetar Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Este, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

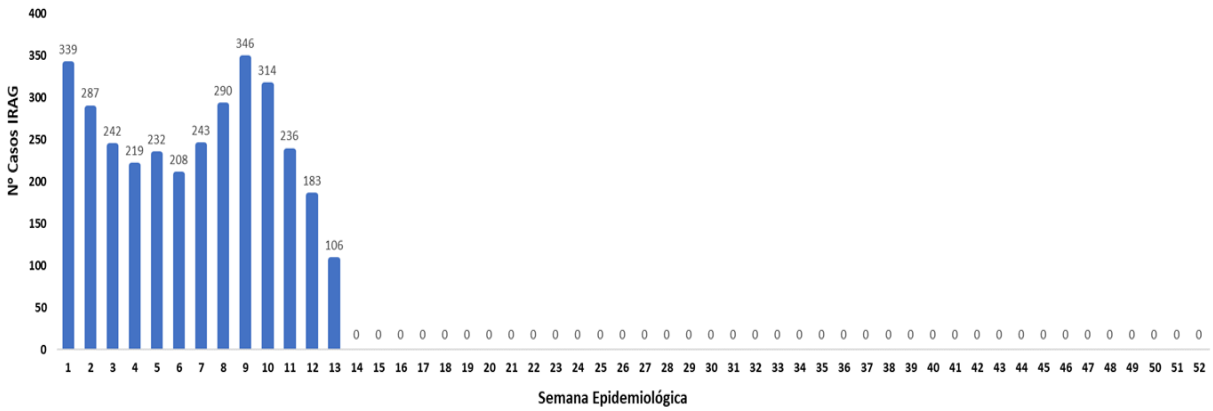
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 13 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 13 del año 2025.

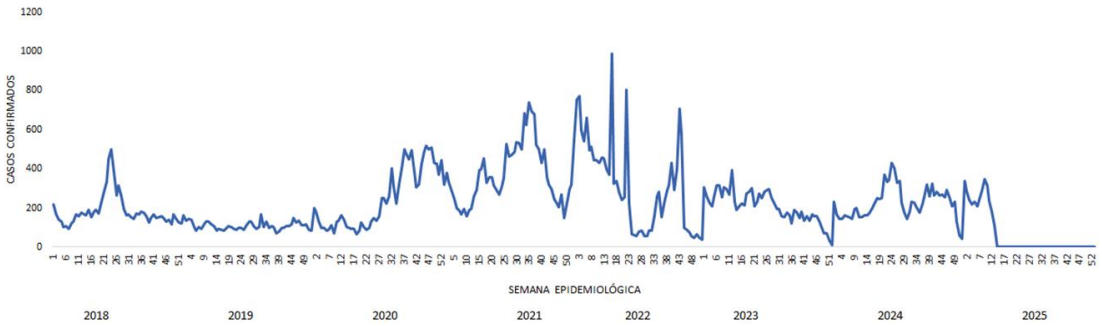
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 13, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

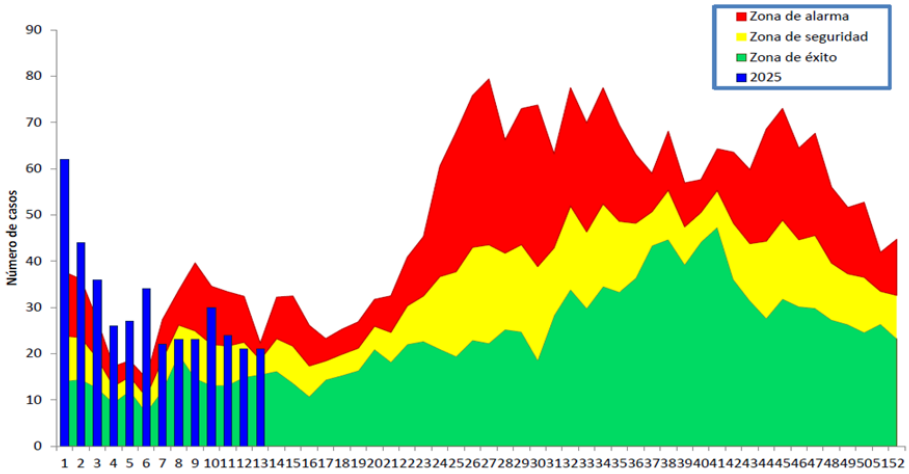
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-13 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de alarma debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

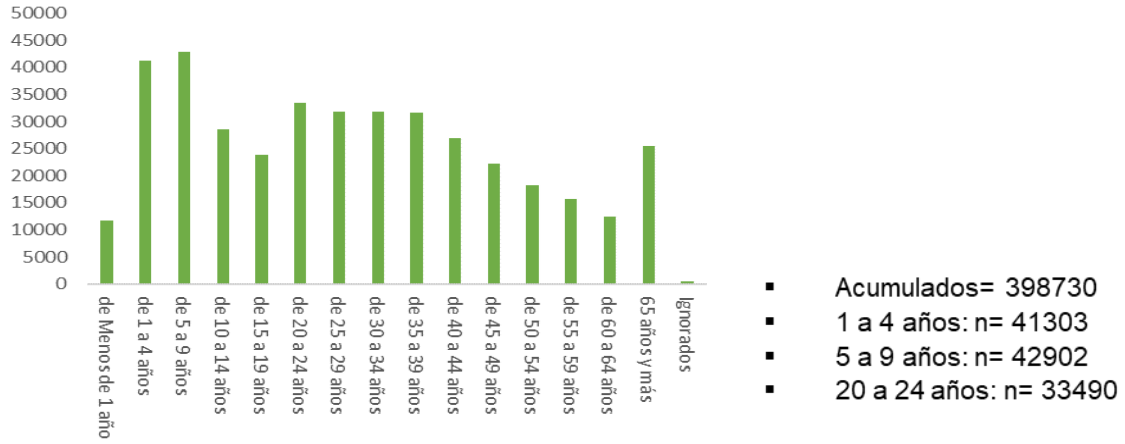


Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 13 son 398730.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y menores entre 5 y 9 años.

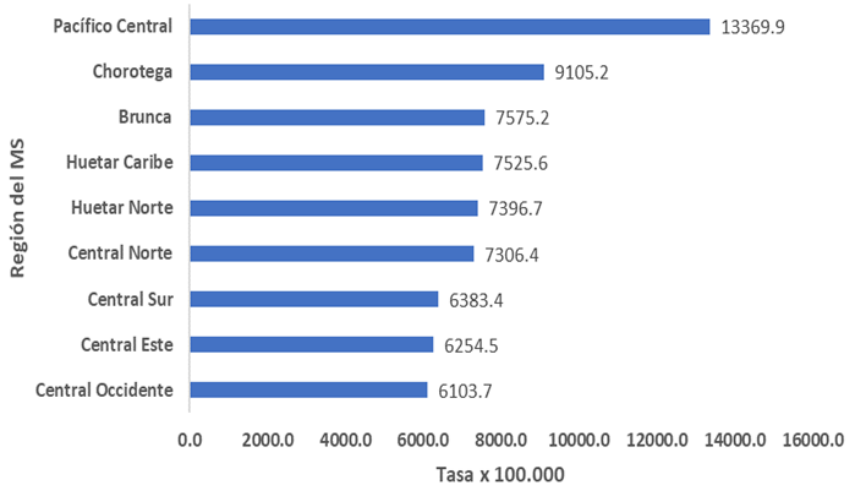
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 13, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 13, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central y Chorotega. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Huetar Norte, Central Norte, Huetar Caribe, Brunca, Central Occidente, Central Sur y Central Este.

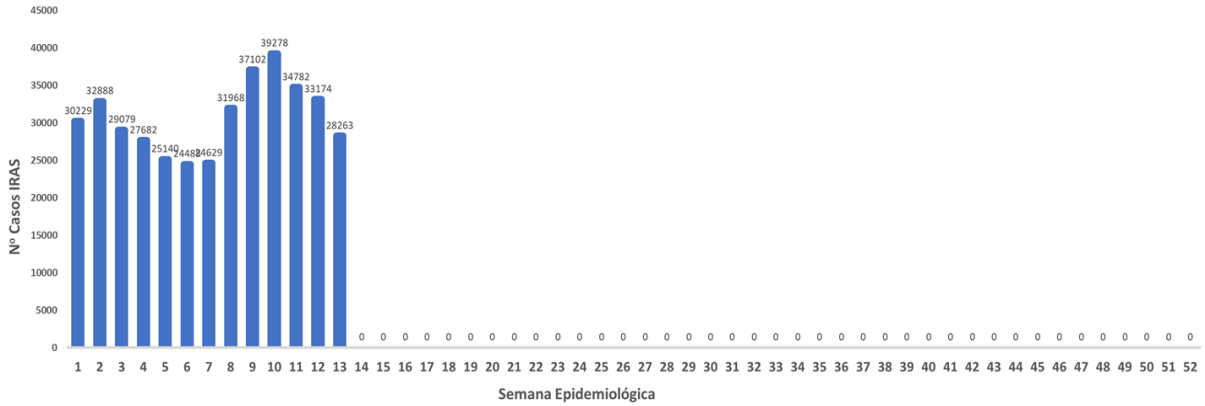
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 13 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 13 semanas epidemiológicas del año 2025.

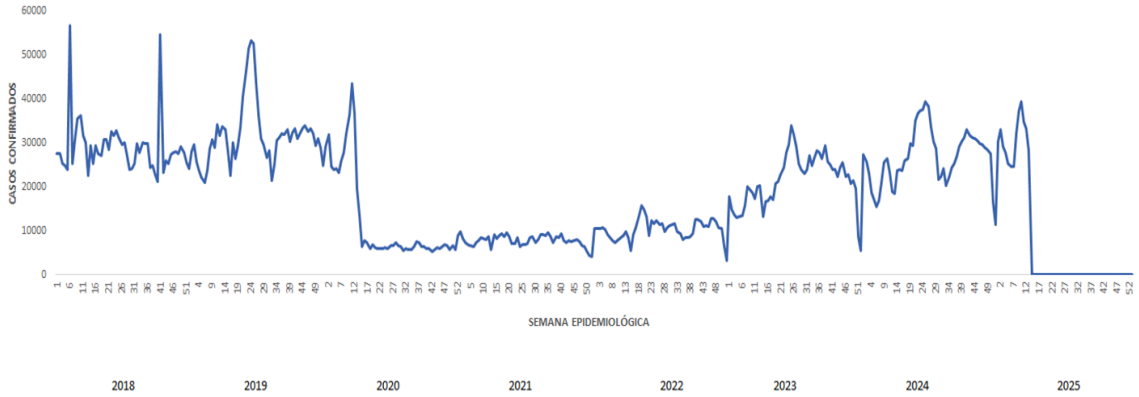
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 13, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

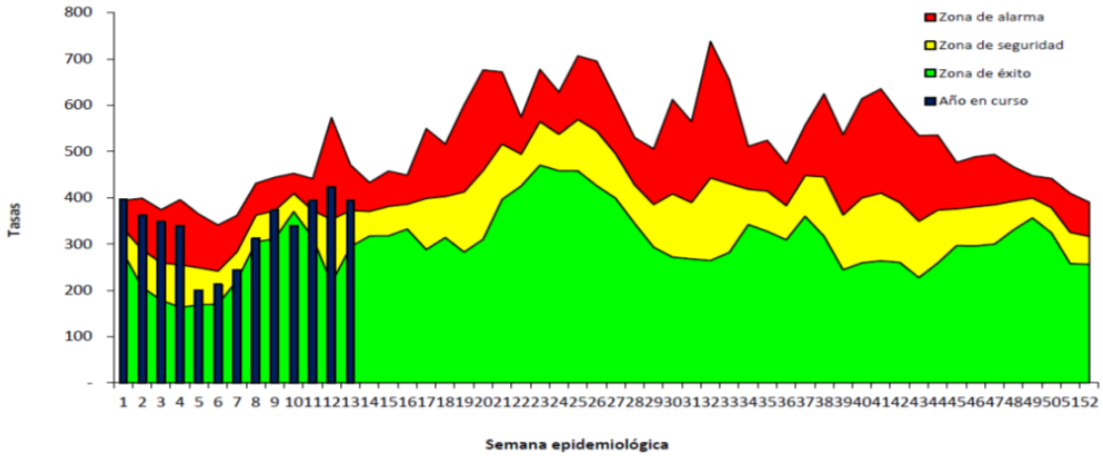
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 13 se encuentran en la zona de alarma actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

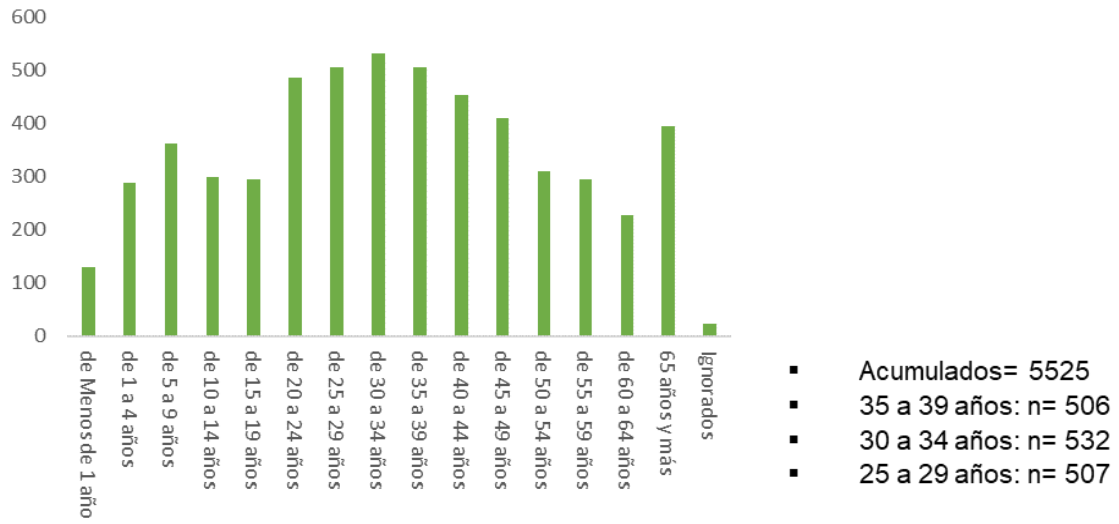


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 13 son n= 5525.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 25 y 29 años.

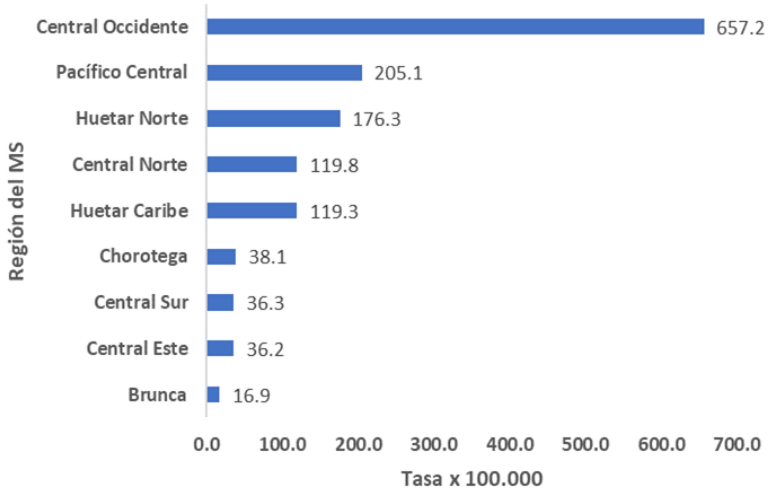
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 13, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 13, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

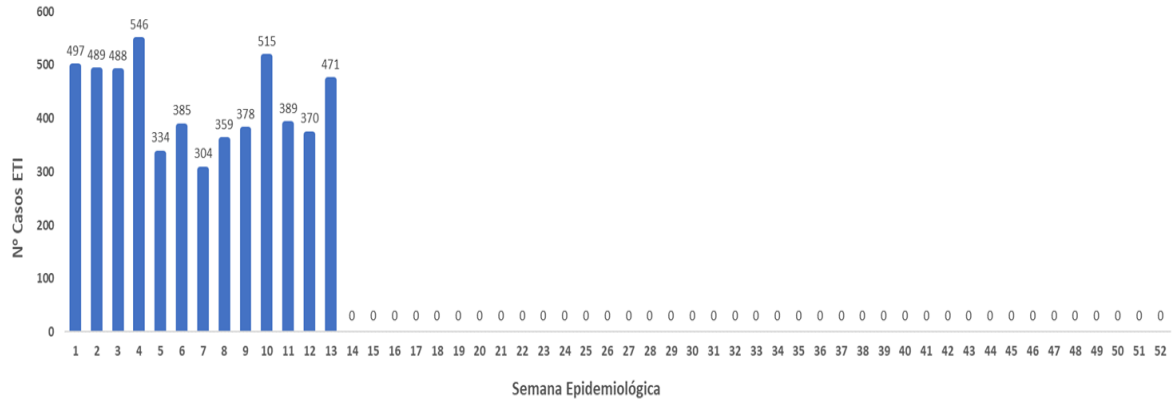
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 13 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025.

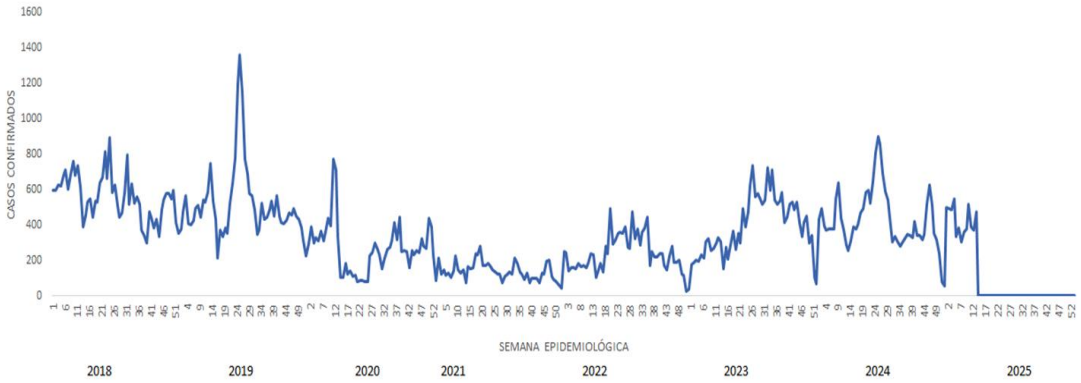
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 13, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

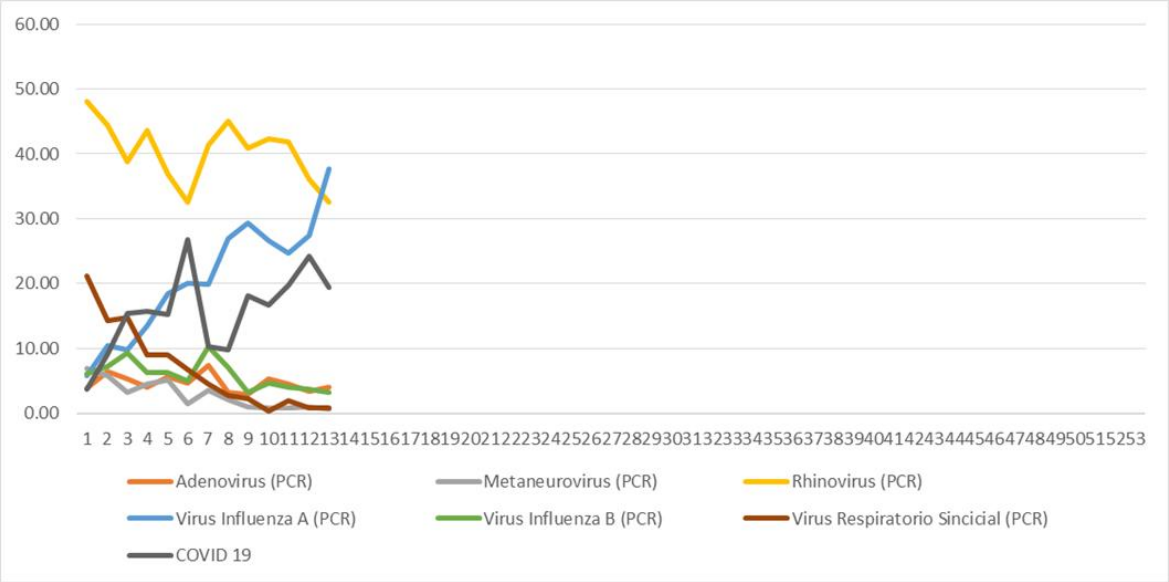
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 13; para la SE-13, en el país el virus de Influenza A es el que más está circulando, seguido del Rinovirus y finalmente, el Covid-19 está en tercer lugar de circulación.

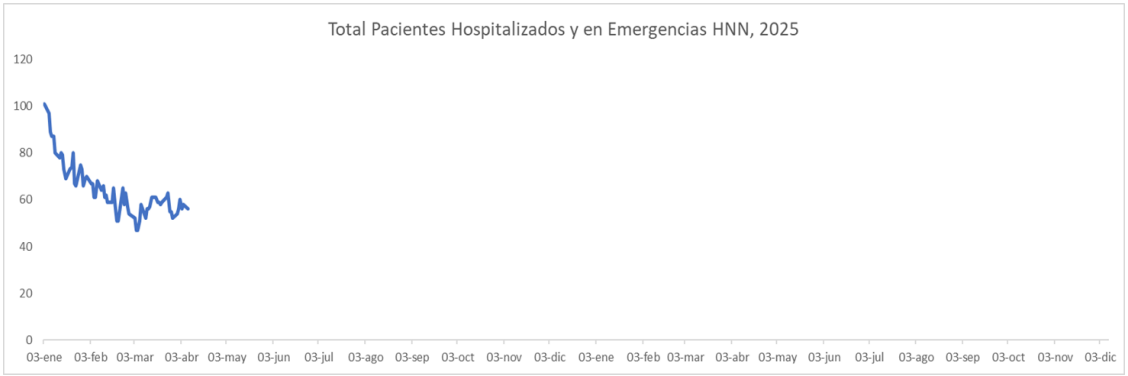
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 13 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 14 del año 2025 es la siguiente:
Al 7 de abril del año en curso, correspondiente a la semana 14, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 52, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 72.0%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 11, 2025, Hospital Nacional de Niños.



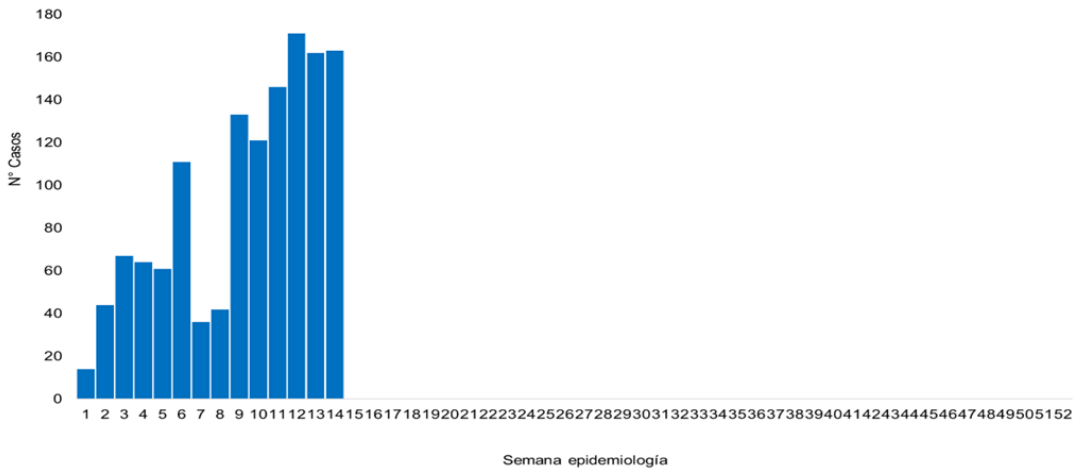
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 3245 casos a la semana 13.
- IRAS con 398730 casos a la semana 13.
- ETI con 5525 casos reportados a la semana 13.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 72.0%
- En SE-13, el Virus de Influenza A es el virus que más ha circulado, seguido del Rinovirus y en tercer lugar circula el Covid-19.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 14, se reportaron un total de 163 casos confirmados, lo que representa un aumento del 0.61% con respecto a la SE-12 del año 2025.

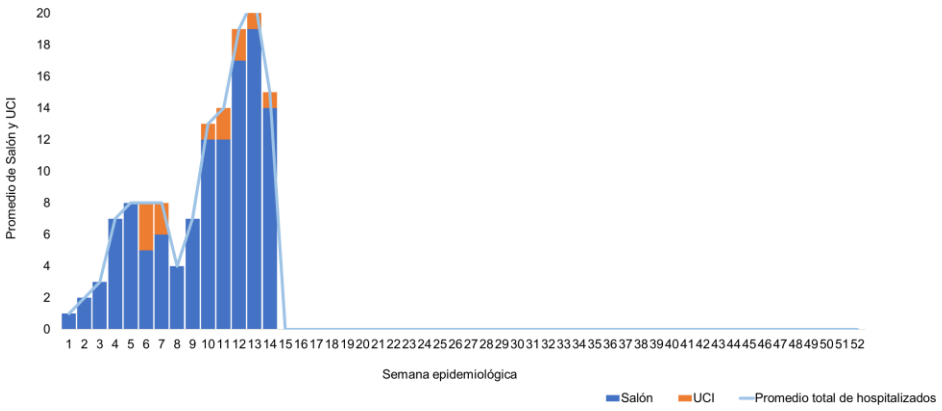
Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2025.



Datos sujetos para actualizar
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 14, se reportó un promedio total de 15 hospitalizados, lo que representa una disminución del 28.57% con respecto a la SE-13 del año 2025.

Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.



Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025

.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 14, no hubo fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

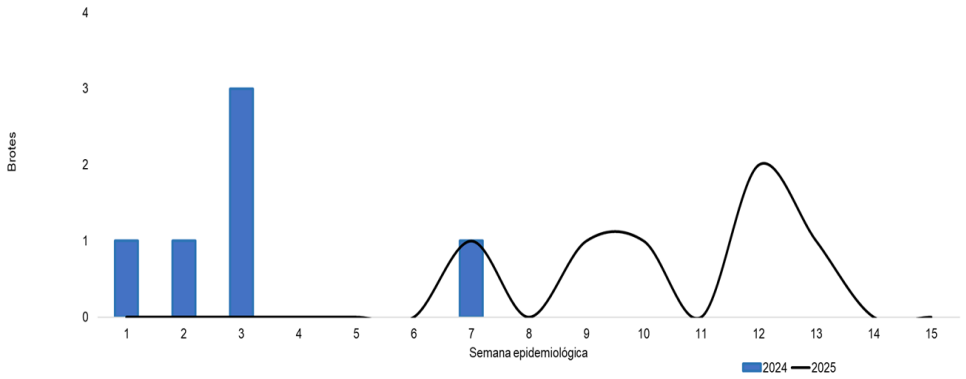
Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2025.



Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

Para la semana epidemiológica 14 no se reportó ningún brote asociado a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2025.



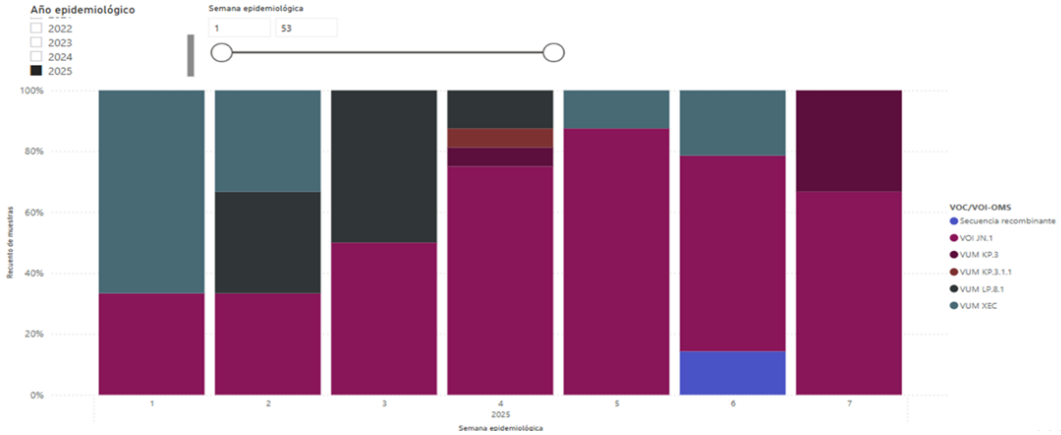
Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Nota: Se reportaron 24 brotes en el año 2024 y se han reportado 6 brotes en el año 2025

Variantes genómicas

Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 7 de abril del 2025, se reporta lo siguiente. (Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, 2025).

Gráfico 21.
Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1-7 del 2025.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 7 de abril del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido en la SE-7 del año 2025, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1.

Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo de las semanas epidemiológicas 1-7 del 2025

Linaje Pangolin	Cantidad	%
Secuencia recombinante	2	3.92
VOI JN.1	34	66.67
VUM KP.3	2	3.92
VUM KP.3.1.1	1	1.96
VUM LP.8.1	5	9.80
VUM XEC	7	13.73
Total	51	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 7 de abril 2025.

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 7 de abril 2025.

Bibliografía

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. (2025). *Informe Interactivo de Vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2 semana 1-2025.* San José: INCIENSA. Obtenido de https://inciensa.sa.cr/Vigilancia%20genomica%20SARS-CoV-2.aspx

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
pamela.dominguez@misalud.go.cr
Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
stephany.alvarado@misalud.go.cr
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
rafael.chaves@misalud.go.cr

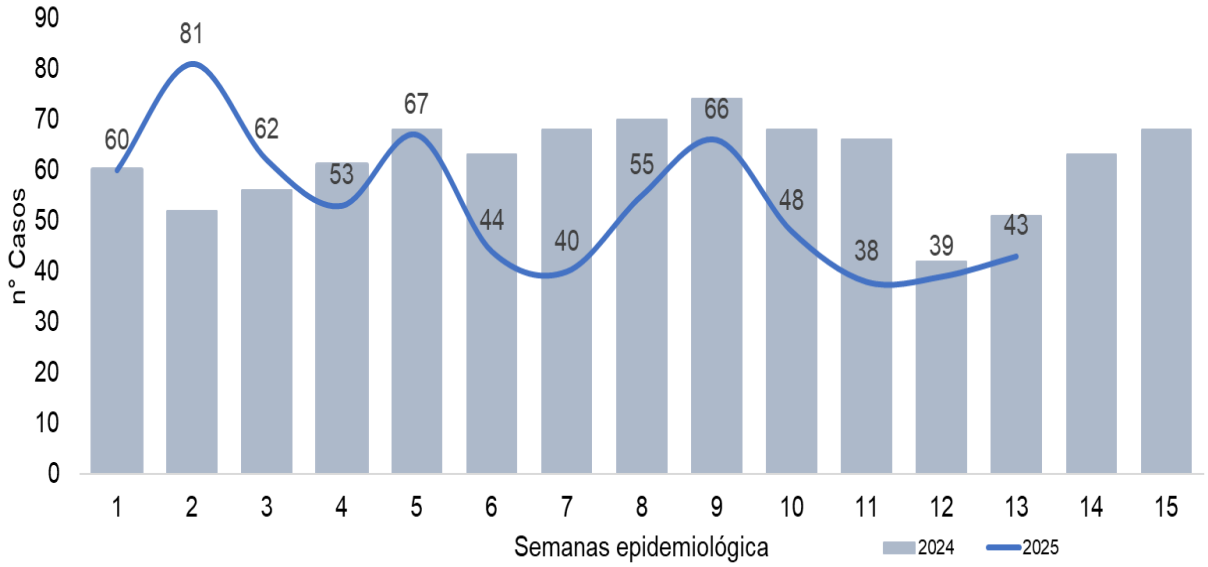
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son de reporte obligatorio según el Reglamento de Vigilancia de la Salud 40556-S. Por consiguiente, la vigilancia es relevante para la salud pública del país. Para las primeras 13 semanas del año 2025, se han reportado las siguientes ITS: Sífilis en todas sus formas, Gonorrea, Herpes Virus y Virus del Papiloma Humano.

Sífilis en todas sus formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Para las primeras 13 semanas del 2025, se han notificado 696 casos con una tasa 13,0 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 799 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 12,89% con 103 casos menos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por Sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de Sífilis en todas sus formas en las primeras 13 semanas del año, en los hombres se reportan un 54,60% de los casos (380/696), y una tasa de 14,1 por 100 000 habitantes, en las mujeres se reportan un 45,40% de los casos (316/696), con una tasa de 11,9 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad, con mayor reporto son: 20 a 64 años con 80,60% (561/696), seguidos por el de mayores de 65 años con 10,80% con (75/696), luego por el grupo de 15 a 19 años con 4,30% con (30/696), y los menores de 1 año con el 4,30% de los con (30/696), con una tasa de 44,41 por 100 000 habitantes, los otros grupos no reportan casos ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de Sífilis en todas sus Formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 13 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	30	44,41
de 1 a 4 años	0	0,00
de 5 a 9 años	0	0,00
de 10 a 14 años	0	0,00
de 15 a 19 años	30	7,90
de 20 a 24 años	82	21,10
de 25 a 29 años	108	25,40
de 30 a 34 años	115	25,89
de 35 a 39 años	69	15,24
de 40 a 44 años	59	14,46
de 45 a 49 años	46	13,25
de 50 a 54 años	35	11,92
de 55 a 59 años	22	7,89
de 60 a 64 años	25	9,55
de 65 a 69 años	22	10,30
de 70 a 74 años	21	13,48
75 años y más	32	15,17
Total	696	13,00

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Cuadro 2. Costa Rica: Casos notificados de Sífilis en Todas sus Formas Según Provincias de procedencia. Números absolutos y Tasas (Tasa p/100.000 habitantes), semana 13 del 2025

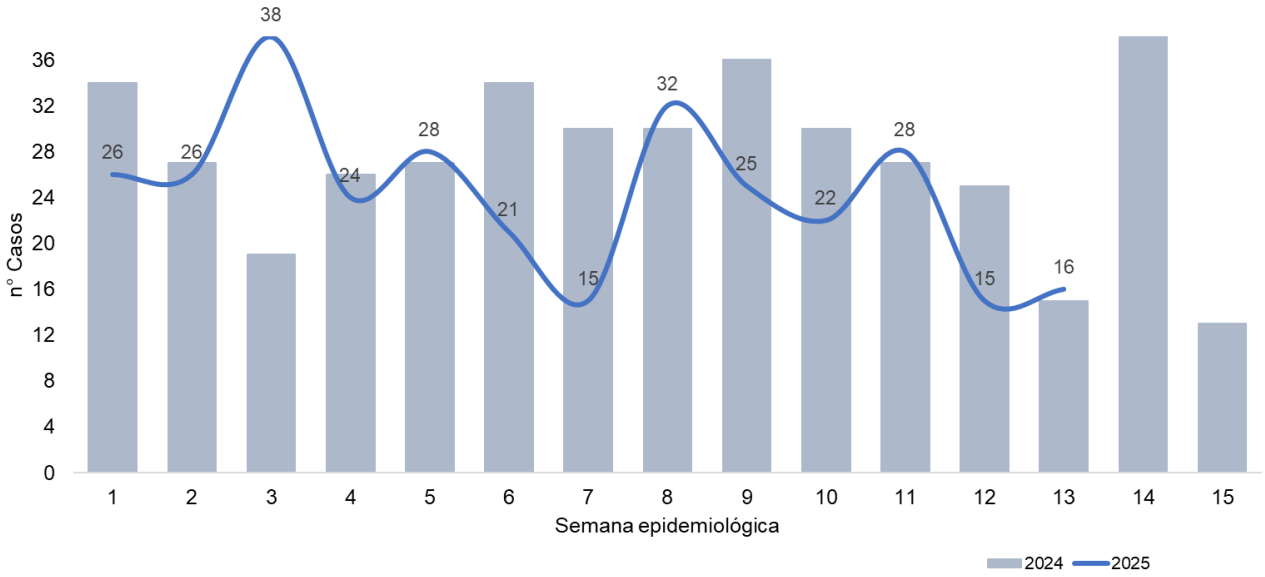
Provincias	Nº	Tasa
San José	229	13,3
Alajuela	101	9,2
Cartago	92	16,5
Heredia	35	6,3
Guanacaste	46	10,9
Puntarenas	70	13,3
Limón	123	25,4
Total	696	13,00

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el parto. Por consiguiente, esta infección afecta a la salud pública del país. En las primeras 13 semanas del 2025, se han notificado 316 casos con una tasa de 5,90 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 360 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 12,22% con 44 casos menos. En el gráfico 2, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por Gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de esta enfermedad en las primeras 13 semanas del año en curso se ha reportado en hombres un 85,44% (230/316), con una tasa de 10 por 100 000 habitantes. En las mujeres se ha reportado el 14.56% (46/316), con una tasa de 1,7 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 82,28% (260/316), seguidos por el grupo de 15 a 19 año con 14,87% (47/316), y los

mayores de 65 años con 2,22% (7/316), los menores de 1 año un caso de 10 a 14 años un caso y los otros grupos sin reporte de casos, ver cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de Gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 13 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0
5 a 9	0	0
10 a 14	1	0,3
15 a 19	47	12,4
20 a 24	78	20,1
25 a 29	65	15,3
30 a 34	42	9,5
35 a 39	31	6,8
40 a 44	19	4,7
45 a 49	7	2
50 a 54	7	2,4
55 a 59	5	1,8
60 a 64	6	2,3
65 a 69	5	2,3
70 a 74	1	0,6
Más 75 años	1	0,5
Total	316	5,90

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por Gonorrea, según provincia.
Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 13 del 2025

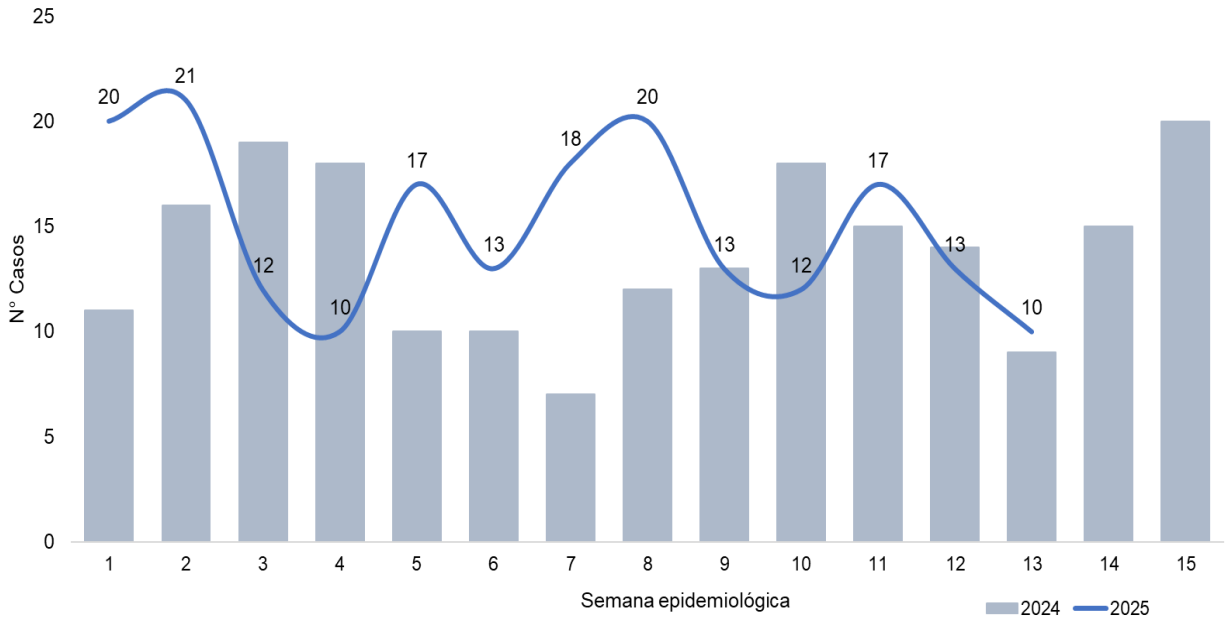
Provincias	Casos	Tasa
San José	116	6,8
Alajuela	49	4,5
Cartago	30	5,4
Heredia	27	4,8
Guanacaste	12	2,9
Puntarenas	30	5,7
Limón	52	10,8
Total	316	5,90

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus Herpes

El Virus del Herpes es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 13 semanas del año en curso, con 196 casos con una tasa de 3,70 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 172 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 13,95%, con 24 casos más que el periodo anterior. En el gráfico 3, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el Virus del Herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del Virus del Herpes en las primeras 13 semanas del año se ha notificado en mujeres un 67,86% de los casos (133/196), con una tasa de 5,0 por 100 000 habitantes, en hombres se reportó el 32,14% de los casos con (63/196), con una tasa de 2,30 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad y los que reportan más son: 20 a 64 años con 80,10% (157/196), seguidos por 15 a 19 años con 14,80% (29/196), mayores de 65 años con 4,08% con (8/196), y el de 10 a 14 años con un 1,02% (2/196), los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de Herpes Virus por grupos de edad, número absoluto y tasa.
Tasa por 100,000 habitantes, en semana 13 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	0	0,0
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	2	0,5
15 a 19	29	7,6
20 a 24	36	9,3
25 a 29	28	6,6
30 a 34	25	5,6
35 a 39	16	3,5
40 a 44	20	4,9
45 a 49	12	3,5
50 a 54	6	2,0
55 a 59	9	3,2
60 a 64	5	1,9
65 a 69	5	2,3
70 a 74	2	1,3
Más 75 años	1	0,5
Total	196	3,70

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 13 del 2025

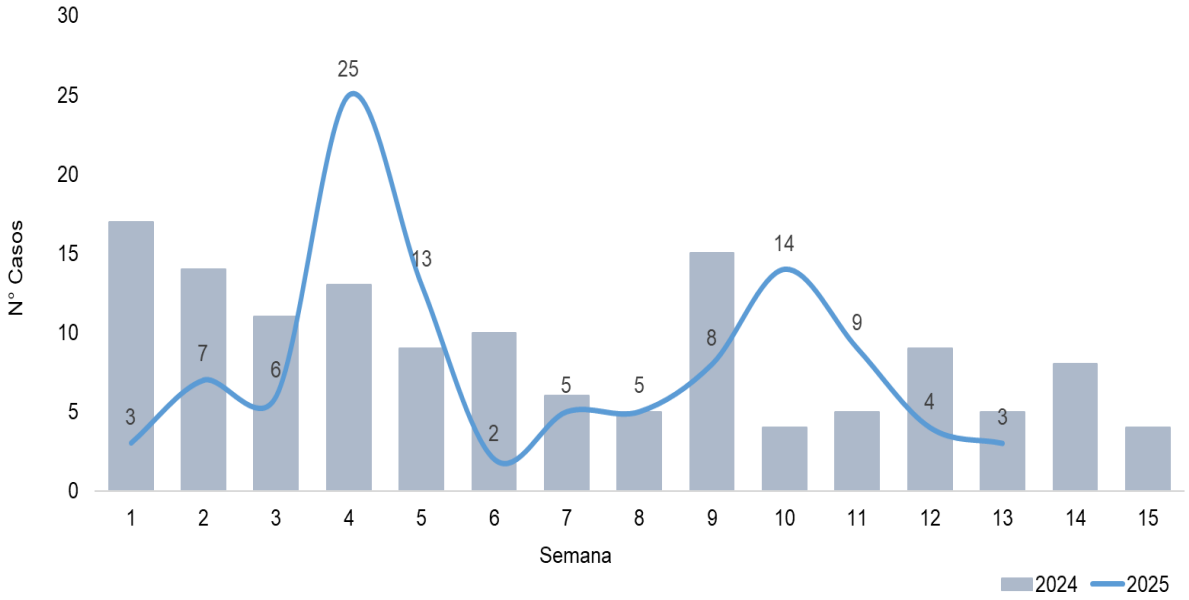
Provincias	Casos	Tasa
San José	92	5,4
Alajuela	19	1,7
Cartago	15	2,7
Heredia	14	2,5
Guanacaste	2	0,5
Puntarenas	22	4,2
Limón	32	6,6
Total	196	3,70

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es una de Infección que se trasmite por por contacto de la piel o por relaciones sexuales, se puede prevenir con el uso de condones y no tener relaciones sexuales cuando la pareja tiene síntomas. En las primeras 13 semanas del 2025, se notificaron 104 casos con una tasas de 1,90 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 123 casos, lo que representa para el años 2025, un descenso del 15,44% con 19 casos menos, ver gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del VPH en las primeras 13 semanas del año, según sexo se notificaron en las mujeres un 90,38% (94/104), con una tasa de 3,50 por 100 000 habitantes, en los hombres se reportó el 9,62% (10/104), con una tasa de 0,40 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 94,20% (98/104), seguidos por 15 a 19 años con 4,80% (5/104), los menores de 1 año presentan un caso y los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 7.

Cuadro 7.
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humanos, por grupos de edad. Número absoluto y tasa.
Tasa por 100,000 habitantes, en semana 13 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	1	1,5
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	0	0,0
de 15 a 19 años	5	1,3
de 20 a 24 años	7	1,8
de 25 a 29 años	12	2,8
de 30 a 34 años	18	4,1
de 35 a 39 años	19	4,2
de 40 a 44 años	14	3,4
de 45 a 49 años	7	2,0
de 50 a 54 años	6	2,0
de 55 a 59 años	7	2,5
de 60 a 64 años	8	3,1
de 65 a 69 años	0	0,0
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	104	1,90

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 8, se presentan el comportamiento de esta enfermedad, según las siete provincias del país.

Cuadro 8.
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según provincia.
Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 13 del 2025

Provincias	Nº	Tasa
San José	17	1,0
Alajuela	7	0,6
Cartago	3	0,5
Heredia	6	1,1
Guanacaste	53	12,6
Puntarenas	16	3,0
Limón	2	0,4
Total	104	1,90

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

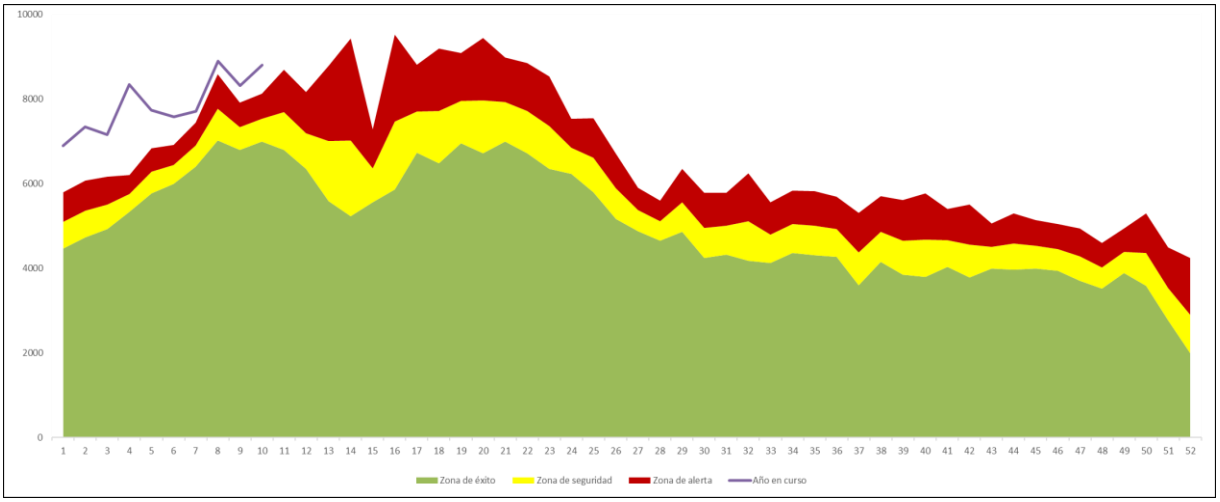
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 8 de abril 2025.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 13 del 2025 se presentan 101839 casos acumulados de EDA. Según el comportamiento epidemiológico de este evento, se denota una curva epidémica en zona de seguridad, con una tasa de 1901,5 casos de diarrea por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de las EDA para la Semana Epidemiológica (SE) 13 refleja una disminución de casos notificados en relación con el 2023, año referente por el registro del aumento de casos y tasas por 100 000 habitantes en todo el territorio nacional. Para la SE 13 se continúa observando una predisposición disminuida en la frecuencia de casos, observándose una tendencia a la baja comparado con los años anteriores, es evidente que los fenómenos climáticos del niño y la niña afectan la cantidad de casos de diarrea, este año con el fenómeno de la niña se muestra a la fecha el canal endémico en zona de seguridad situación semejante en el año 2023 donde se atravesó el mismo fenómeno.

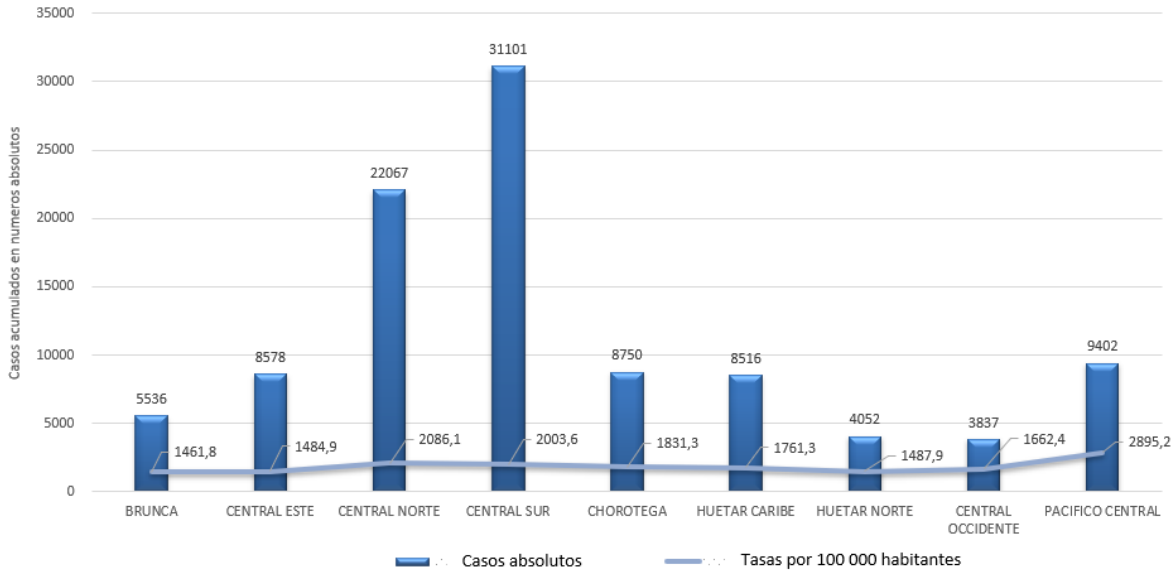
Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 13. Años 2017- 2025. (Se excluyen del 2020 al 2022 por pandemia COVID-19)



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Los 10 cantones con mayores tasas de incidencia de EDA a la SE 11 son: Montes de Oro, Orotina, Puntarenas, San Rafael, Valverde Vega, Garabito, Parrita, Vázquez de Coronado, Santa Cruz, Tarrazú, donde predominan las tasas más altas. Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur y Chorotega. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2.
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 13, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Se recomienda retomar las campañas de educación a la población del Protocolo de Lavado de Manos, las adecuadas prácticas de higiene personal y de cocción y manipulación de alimentos.
El sistema de salud reporta una alta frecuencia de casos de diarreas, ya sean virales o bacterianas, superiores al comportamiento usual, el Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos dirige el proceso de la investigación adecuada de los casos, así como los flujogramas de trabajo ante diferentes posibles causas, es importante retomar las actividades de vigilancia e investigación ante las alertas.

Intoxicación por metanol

Datos al 8 de abril del 2025

Ted Alpízar Calvo
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

La intoxicación por metanol un alcohol tóxico, no apto para bebidas es una de las patologías de más alta mortalidad en urgencias. Al ser una patología no común y con síntomas y signos no específicos muchas veces la pasamos por alto y con esto aumentamos su mortalidad. Este es uno de los padecimientos que ante la alta sospecha en la historia clínica y sintomatología debemos abordar de inmediato con el fin de evitar un desenlace fatal. Sus síntomas se deben principalmente al acúmulo de ácido fórmico que causa alteraciones pulmonares, metabólicas, neurológicas y renales. Es un padecimiento el cual debe notificarse una vez confirmado el diagnóstico con el fin de realizar un barrido y encontrar los causantes, antes de evitar brotes mayores.

El Decreto de Vigilancia de la Salud N° 40556-S, indica que la intoxicación con metanol es de notificación obligatoria al Ministerio de Salud debido a su impacto en la salud pública; ya que puede causar un cuadro grave de intoxicación, discapacidad en la persona e inclusive la muerte, si no se trata oportunamente. Por este motivo, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son cruciales para mejorar el pronóstico.

El Ministerio de Salud de Costa Rica haciendo uso de sus potestades, que le confiere la legislación, establece los lineamientos que deben seguir los establecimientos de salud públicos y privados, cuando se presenten casos de intoxicación con metanol. Se pretende con los lineamientos orientar al personal de salud, en los procedimientos a seguir para evitar las discapacidades y la mortalidad que podrían producir este tipo de intoxicación.

Datos

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro, indicador seleccionado por sexo. Del 1 de enero al 8 de abril 2025.

Indicador	**Sexo biológico notificado**		
Morbilidad	**Mujeres**	**Hombres**	**Total**
Número de casos (vivos)	0	1	1
Porcentaje (%) del total	0	100 %	100 %
Rango edad (años)	0	49	49
Promedio edad (años)	0	49	49
Edad desconocida	0	0	0
Mortalidad			
Número de casos (fallecidos)	1	0	1
Porcentaje (%) del total	100 %	0	100 %
Rango edad (años)	48	0	48
Promedio de edad (años)	48	0	48
Edad desconocida	0	0	0
Total (número de vivos y fallecidos)	1	1	2

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 2.
Costa Rica: Casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro, por provincia, cantón y condición de egreso. Del 1 de enero al 8 de abril 2025

Provincia	**Cantón**	**Condición de egreso**		**Total**
		Fallecidos	**Vivos**	
San José	San José	1	1	2
Total (2025)		1	1	2

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 3.
Costa Rica: Casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro por grupos de edad y por condición egreso. Del 1 de enero al 8 de abril 2025

Grupos de edad (años)	Condición de egreso		Total
	Fallecido	Vivo	
20-29			
30-39			
40-49	1	1	2
50-59			
60-69			
70 y mas			
Desconocido			
Total			2

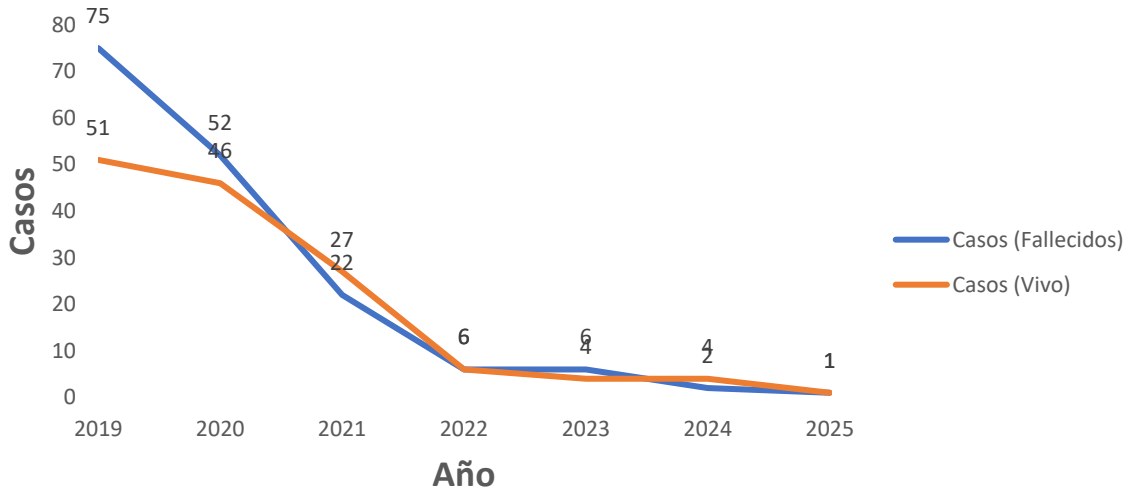
Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Cuadro 4.
Costa Rica: Casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por metanol según fecha de registro por condición y año de ocurrencia. Del 1 de enero al 8 de abril 2025

Condición	Año de ocurrencia							Total
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Casos (Fallecidos)	75	52	22	6	6	2	1	164
Casos (Vivo)	51	46	27	6	4	4	1	139
Total (2019-2024)	**126**	**98**	**49**	**12**	**10**	**6**	**2**	**303**

Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.

Gráfico 1.
Curva de casos vivos y casos fallecidos, sospechosos por Intoxicación por Metanol según fecha de registro por condición y año de ocurrencia.



Fuente: Dirección Vigilancia de la Salud con información proporcionada de los establecimientos de salud de la CCSS y el OIJ.